

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

INVENTARIO DE HOSTILIDAD DE BUSS-DURKEE (BDHI)

Buss-Durkee Hostility Inventory (Buss & Durkee, 1957) · Adaptación Española (Bobes et al., 2004)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Inventario de Hostilidad de Buss-Durkee (Buss-Durkee Hostility Inventory, BDHI)
Sigla / Acrónimo	BDHI
Autoría original	Arnold H. Buss & Ann Durkee (1957, Journal of Consulting Psychology)
Adaptación en español	Bobes García, García-Portilla, Bascarán et al. (2004, Banco de Instrumentos / CIBERSAM)
Constructo evaluado	Diferentes tipos y manifestaciones cognitivas, emocionales y conductuales de la agresividad y hostilidad
Población diana	Adultos y adolescentes en psiquiatría clínica, medicina psicosomática, contextos periciales y forenses
Tiempo de aplicación	10 a 15 minutos (autoadministrado)
Estructura y formato	75 ítems dicotómicos (Verdadero / Falso) agrupados en 7 subescalas de agresión más 1 de culpa
Condiciones de uso	Dominio público para uso asistencial e investigación académica citando a los autores originales

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La agresividad no es un rasgo unitario, sino un constructo conductual multidimensional que integra componentes motores directos (agresión física), verbales (insultos, gritos), afectivos (ira, irritabilidad) y cognitivos (resentimiento, suspicacia y hostilidad cínica). Buss y Durkee diseñaron el BDHI con el objetivo pionero de descomponer la conducta hostil en sus facetas operativas específicas.

A nivel psicosomático y cardiovascular, las dimensiones cognitivas del BDHI (resentimiento y suspicacia) han demostrado ser factores predictivos independientes de enfermedad coronaria, hipertensión arterial y disfunción endotelial, mediado por hiperreactividad simpaticoadrenal y elevación crónica de citocinas inflamatorias. En el ámbito forense y penitenciario, las subescalas de agresión física e indirecta son marcadores esenciales para el triaje de peligrosidad y riesgo de violencia interpersonal.

3. LAS 8 SUBESCALAS CLÍNICAS DEL INVENTARIO BDHI

Subescala	Nº Ítems	Rango	Contenido y Definición Operativa
1. Violencia (Agresión Física)	10 ítems	0 - 10	Uso de la fuerza física y peleas contra otros (ítems 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 70)
2. Hostilidad Indirecta	9 ítems	0 - 9	Agresión vicaria o disimulada (dar portazos, maledicencias, rabi-etas)
3. Irritabilidad	11 ítems	0 - 11	Bajo umbral de frustración, exasperación rápida y mal genio
4. Negativismo	5 ítems	0 - 5	Conducta oposicionista ante figuras de autoridad o reglas sociales
5. Resentimiento	8 ítems	0 - 8	Envidia, celos y sensación de haber sido tratado injustamente
6. Suspicacia	10 ítems	0 - 10	Proyección de hostilidad hacia los demás; desconfianza paranoide
7. Hostilidad Verbal	13 ítems	0 - 13	Expresión vocal agresiva: gritos, insultos, amenazas y discusiones
8. Sentimiento de Culpa	9 ítems	0 - 9	Remordimiento y autorreproche moral posterior a la agresión

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y ESTRUCTURA FACTORIAL

Consistencia interna	Fiabilidad global satisfactoria; alfa de Cronbach de la escala total de hostilidad $\alpha = 0.82 - 0.86$; subescalas individuales con alfas entre 0.62 y 0.80 (Bobes et al., 2004).
Estabilidad temporal	Fiabilidad test-retest a 4 semanas: coeficientes de Pearson $r = 0.76 - 0.82$, reflejando una adecuada estabilidad temporal como rasgo de personalidad.
Estructura factorial	Los análisis factoriales de segundo orden revelan consistentemente dos macrofactores principales: 1) Agresión Manifiesta (Violencia, Irritabilidad y Hostilidad Verbal); y 2) Hostilidad Encubierta / Neuroticismo (Resentimiento y Susplicia).
Validez convergente	Correlación muy alta con el Cuestionario de Agresión de Buss-Perry (AQ, $r = 0.81$) y con las escalas de Ira del STAXI-2 ($r = 0.74$).
Rendimiento forense	Discrimina con alta significación estadística ($p < 0.001$) entre reclusos con delitos violentos graves vs. controles comunitarios.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Formato dicotómico	Cada ítem se responde como Verdadero o Falso . Se asigna 1 punto si coincide con la clave patológica hostil.
Puntuación de subescalas	Se suma el número de aciertos de cada una de las 8 subescalas independientes según sus plantillas de corrección correspondientes.
Índice de Hostilidad Total	Suma de las 7 subescalas de agresión (excluyendo la subescala de Culpa): Hostilidad Total = Violencia + H. Indirecta + Irritabilidad + Negativismo + Resentimiento + Susplicia + H. Verbal . Rango: 0 a 66 puntos .
Función de la Culpa	La subescala de Culpa (0-9) se analiza como modulador o inhibidor interno: sujetos con alta hostilidad y baja culpa presentan mayor riesgo de reincidencia violenta.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntaje Total (0-66)	Percentil	Nivel de Hostilidad	Significación Clínica y Riesgo Psicosocial
0 - 24 puntos	< Pc 40	Baja Hostilidad / Pacífico	Patrón normativo adaptativo; baja conflictividad interpersonal.
25 - 38 puntos	Pc 40 - Pc 75	Hostilidad Moderada	Nivel medio en población urbana; reactividad ante provocación.
39 - 50 puntos	Pc 80 - Pc 94	Hostilidad Alta Patológica	Frecuentes conflictos laborales y familiares; riesgo cardiovascular.
51 - 66 puntos	$\geq$ Pc 95	Hostilidad Muy Severa / Extrema	Marcado descontrol de impulsos agresivos; alto riesgo de violencia física.

PUNTOS DE CORTE Y PATRÓN DE ALTO RIESGO FORENSE:

- **Hostilidad Total ≥ 39 puntos:** Define niveles clínicamente elevados de agresividad.
- **Patrón de Riesgo Violento Inminente:** Violencia (Agresión Física) $\geq \frac{7}{10}$ combinado con Susplicia $\geq \frac{7}{10}$ y Culpa $\leq \frac{2}{9}$. Este perfil refleja predisposición al paso al acto agresivo justificado paranoicamente y sin freno inhibitorio moral.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE GESTIÓN CLÍNICA DE LA CONDUCTA HOSTIL

Paso 1: Medición con BDHI: Calcular el total de Hostilidad (0-66) y el desglose de subescalas.

Paso 2: Si predomina el Macrofactor Manifiesto (Violencia + Hostilidad Verbal altas):

- Descartar intoxicación exógena por estimulantes/alcohol o episodio maniaco/mixto.
- Iniciar entrenamiento en control de la ira (**Anger Management**), tiempo fuera (**time-out**) y técnicas de desescalada fisiológica.

Paso 3: Si predomina el Macrofactor Encubierto (Suspiciencia + Resentimiento altos):

- Evaluar personalidad paranoide o psicosis incipiente.
- Reestructuración cognitiva de sesgos de atribución hostil (evitar interpretar ambigüedad como agresión deliberada).

Paso 4: En Pacientes Cardiovasculares: Si Suspiciencia y Resentimiento son elevados, incluir en programas de manejo de estrés para reducción del riesgo coronario secundario.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN INTERCONSULTA PSIQUIÁTRICA

Identificación: Varón de 38 años, derivado por Salud Laboral tras protagonizar incidentes violentos reiterados con compañeros de trabajo y romper mobiliario en momentos de tensión.

Evaluación BDHI Inicial: Hostilidad Total = **48 / 66** (Percentil 92, Hostilidad Muy Alta).

- Violencia física = 8/10; Hostilidad Verbal = 11/13; Irritabilidad = 9/11; Suspiciencia = 8/10; Resentimiento = 6/8; Sentimiento de Culpa = 1/9 (nulo remordimiento, consideraba que "los demás lo provocaban").

Diagnóstico: Trastorno Explosivo Intermitente asociado a Rasgos Paranoides de la Personalidad.

Tratamiento: Programa de 12 sesiones de TCC para manejo de la ira y reestructuración de sesgos paranoides, asociado a valproato sódico 500 mg/12h como modulador de la impulsividad agresiva.

Evolución a los 4 meses: La Hostilidad Total se redujo a **26 / 66** (rango normal/moderado), la violencia física bajó a 2/10 y no se registraron nuevas conductas agresivas en su puesto laboral.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgo de Violencia:

- **Amenazas Específicas de Agresión:** Todo reporte de violencia física con víctimas designadas exige medidas de protección a terceros y notificación judicial.
- **Suspiciencia Delirante:** Descartar delirios persecutorios activos donde la agresión se ejecuta en "legítima defensa delirante".

Diagnóstico Diferencial:

- **Hostilidad vs. Agresividad Instrumental:** El BDHI mide reactividad emocional agresiva; los psicópatas puros pueden agredir friamente sin puntuaciones altas de ira.
- **Trastorno por Uso de Sustancias:** La abstinencia alcohólica o el consumo de psicoestimulantes cursan con elevaciones masivas transitorias de irritabilidad.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Buss, A. H., & Durkee, A. (1957). An inventory for assessing different kinds of hostility. *Journal of Consulting Psychology*, 21(4), 343-348. <https://doi.org/10.1037/h0046900>
- Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3ª ed.). Ars Medica / Psiquiatría Editores.
- Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The aggression questionnaire. *Journal of Personality and Social Psychology*, 63(3), 452-459.
- Barefoot, J. C., Dodge, K. A., Peterson, B. L., & Dahlstrom, W. G. (1989). The Cook-Medley hostility scale: item content and ability to predict survival. *Psychosomatic Medicine*, 51(1), 46-57.